

Турбина Ю.О., Полунина Н.В., Полунин В.С.

ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, кафедра общественного здоровья и здравоохранения, экономики здравоохранения, 117997, г. Москва

♦ **Актуальность исследования.** В России число женщин репродуктивного возраста составляет 38% от общей численности женского населения, имеет место отрицательные естественный прирост населения. *Цель* – изучение медико-социальных аспектов здоровья женщин фертильного возраста (18–45 лет). *Материалы и методы:* изучение наблюдаемых женщин проводилось в течение трех лет (2016–2018 гг.) по данным медицинской документации и результатам анкетирования в г. Москве. *Результаты.* Основная масса наблюдаемых женщин – работающие, средний возраст рождений женщиной ребенка составил возраст 25–29 лет, более 80% женщин осуществили прерывание беременности, 20,8% женщин имеют гинекологические заболевания: патология эндометрия матки и яичников (44% и 27% соответственно), 12% – имели осложнения течения беременности и родов, нерегулярный менструальный цикл имеют 55,3% женщин. На каждую женщину в среднем приходится 1,3 заболевания, наиболее частым заболеванием являются болезни органов дыхания. По уровню здоровья наблюдаемые женщины почти равномерно распределены на женщин с хорошим здоровьем 35%, с удовлетворительным здоровьем – 37%, с плохим здоровьем – 28%. *Заключение.* В целях улучшения состояния здоровья наблюдаемых женщин и повышения их медицинской активности среди них были проведены профилактические беседы по формированию у них здорового образа жизни, которые целесообразно проводить постоянно.

Ключевые слова: женщины; социально-гигиеническая характеристика, репродуктивный возраст, заболеваемость, здоровый образ жизни.

Для цитирования: Турбина Ю.О., Полунина Н.В., Полунин В.С. Особенности здоровья женщин репродуктивного возраста. *Российский медицинский журнал.* 2019; 25(4): 199–201. DOI <http://dx.doi.org/10.18821/0869-2106-2019-25-4-199-201>

Для корреспонденции: Полунин Валерий Сократович, доктор мед. наук, профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения, экономики здравоохранения ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова», 117997, Москва, E-mail: lunapol@yandex.ru

Turbine Yu.O., Polunina N.V., Polunin V.S.

HEALTH FEATURES OF WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

N.I. Pirogov Russian National Research Medical University, Department of Public Health and Health, Health Economics, 117997, Moscow, Russian Federation

♦ **The relevance of the study.** In Russia, the number of women of reproductive age makes up 38% of the total female population, there is a negative natural increase in the population. *The aim* is to study the medical and social aspects of the health of women of childbearing age (18–45 years). *Materials and methods:* the study of observed women was conducted for three years (2016–2018) according to medical records and questionnaire results in Moscow. *The results.* The majority of observed women are working, the average age of births by a woman of a child was 25–29 years, more than 80% of women performed abortion, 20.8% of women have gynecological diseases: pathology of the endometrium of the uterus and ovarian (44% and 27% respectively), 12% – had complications of pregnancy and childbirth, irregular menstrual cycle have 55.3% of women. For every woman, on average there are 1.3 diseases, the most common disease is respiratory diseases. In terms of health, women observed are almost evenly distributed to women with good health 35%, with satisfactory health – 37%, with poor health – 28%. *The conclusion.* In order to improve the health of the women observed and increase their medical activity, preventive interviews were conducted among them on the formation of a healthy lifestyle, which is advisable to conduct constantly.

Keywords: women; social and hygienic characteristics; reproductive age; morbidity; healthy lifestyle.

For citation: Turbine Yu.O., Polunina N.V., Polunin V.S. Health features of women of reproductive age. *Rossiiskii meditsinskii zhurnal (Medical Journal of the Russian Federation, Russian journal).* 2019; 25(4): 199–201. (in Russ)
DOI <http://dx.doi.org/10.18821/0869-2106-2019-25-4-199-201>

For correspondence: Valery S. Polunin, doctor of medical sciences, Professor of public health and health care, health economics, N.I. Pirogov Russian National Research Medical University, 117997, Moscow, Russian Federation, E-mail: lunapol@yandex.ru

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Acknowledgments. The study had no sponsorship.

Received 12.09.19
Accepted 26.09.19

Актуальность проблемы

В России по состоянию на 1 января 2018 г. число женщин репродуктивного возраста (от 15 до 44 лет) составляет 29,95 млн. (38% от общей численности женского населения), начиная с возраста 35 лет число женского населения превышает число мужского населения. Показатель рождаемости составляет 11,5‰, смертности – 12,4‰, естественный прирост населения -0,9‰, младенческая смертность – 5,6‰. Суммарный коэффициент рождаемости 1,62 детей (норма 2,1), родившихся живыми на 1 женщину. Основными причинами смертности детей до 1 года являются врожденные аномалии (по-

роки развития), деформации, хромосомные нарушения и отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде. Наблюдается рост заболеваемости детей с 659,5‰ до 1044,4‰ (с 2000 по 2017 г.) Более половины зарегистрированных браков распадается, чаще всего женщины вступают в брак в возрасте 25–34 лет [1]. Исследование, проведенное Гараевой А.С. (2017 г.), выявило, что среди наблюдаемых женщин фертильного возраста первое место в заболеваемости занимают болезни органов дыхания (163,1‰), второе – болезни органов пищеварения (142,4‰), третье – болезни системы кровообращения (135,8‰), четвертое – болезни мочеполо-

вой системы (97,5%), пятое место разделяют 3 группы заболеваний – болезни кожи и подкожной клетчатки (56,8%), болезни глаз (56,6%), заболевания костно-мышечной системы (55,0%), в целом указанная заболеваемость составляет 68,7% от всей общей заболеваемости женщин в год (1028,4%). Одно экстрагенитальное заболевание было выявлено у 43,1% женщин, два – у 37,9% женщин, три и более – у 17,9% женщин, нарушения регулярности менструального цикла имела место у каждой второй женщины (55,3%), при этом было отмечено, что с увеличением числа беременностей растет уровень заболеваемости [2]. При обследовании женщин была зарегистрирована уровень соматической заболеваемости в 996,8%, на первом месте были болезни крови и кроветворных органов (300,8%), на втором – болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (172,9%), на третьем – болезни органов пищеварения (98,8%), на четвертом – болезни системы кровообращения (88,9%), на пятом – болезни нервной системы и органов чувств (83,9%). Максимальная распространенность в гинекологической патологии среди обследованных женщин принадлежала миоме матки (20,3%), заболеваниям молочных желез (18,9%), воспалительным заболеваниям органов малого таза (16,8%), эндометриозу (14%). В среднем у одной женщины отмечалось 1-2 хронических заболеваний, большинство женщин имели низкую медицинскую активность [3]. Изучение репродуктивного здоровья сельских жительниц фертильного возраста показало, что в структуре заболеваемости женщин фертильного возраста болезни органов дыхания составили 30,1%, болезни мочеполовой системы – 14,0%, болезни эндокринной системы – 10,7%; онкопатология – 10,4%, болезни органов пищеварения – 9,5%, заболеваемость репродуктивной системы составила 4385,6‰ [4]. В целом заболеваемость женщин по субъективным и объективным показателям выше, чем у мужчин [4]. Указанные статистические данные свидетельствуют о том, что доля женщин репродуктивного возраста недостаточна для полноценного воспроизводства населения, показатель смертности превышает показатель рождаемости и обуславливает отрицательный естественный прирост населения, причины младенческой смертности обусловлены поздним возрастом рождения матерью первого ребенка. В структуре

общей заболеваемости женщин основными заболеваниями являются болезни органов дыхания, пищеварения, в гинекологической – миома матки, эндометриоз, заболевания молочной железы.

Цель. Изучение медико-социальных аспектов здоровья женщин фертильного возраста (18-45 лет).

Материал и методы

Изучение наблюдаемых женщин проводилось в течение трех лет (2016-2018 гг.) по данным медицинской документации и результатам анкетирования. Были разработаны выборочные карты по изучению гинекологической и экстрагенитальной заболеваемости, а также анкета по изучению социально-гигиенической характеристики женщин фертильного возраста, анкета по изучению их репродуктивного поведения и медицинской активности. При проведении исследования были изучены 1242 выборочных карт для анализа заболеваемости женщин, 802 анкеты по изучению социально-гигиенической характеристики и 599 анкет по изучению репродуктивного поведения и медицинской активности женщин фертильного возраста. В целом исследование проводилось по следующей программе (см. рисунок).

Результаты

Средний возраст обследуемых женщин составил $32 \pm 0,2$ года. Две трети наблюдаемых женщин (65%) были работающими, каждая пятая – домохозяйкой, каждая десятая – студентки, 7% женщин имели высшее образование, две трети женщин состояли в браке, 70% имели детей (большинство одного ребенка), в том числе из них более 80% планировали еще рождение детей и регулярно проходили наблюдение врачом акушером-гинекологом. Средний возраст рождений женщиной ребенка составил возраст 25-29 лет. Каждая третья женщина имела в анамнезе аборт и из них у каждой седьмой женщины были осложнения при последующей беременности. Более 80% женщин осуществляли прерывание беременности по собственному желанию, остальным операция прерывания беременности была проведена по медицинским показаниям, из них половина женщин проводили прерывание беременности в условиях частной медицинской организации, большинство женщин (62,1%) относятся к абортам негативно. Установлено, что половина женщин наблюдаются в частной клинике, треть в женской консультации (39,8%), остальные – у семейного врача (27,7%). Наибольшее количество обращений женщин в медицинские организации связано с беременностью (80,8%) при проведении профилактических осмотров. Только 60,7% женщин отмечают своевременное обращение к врачу при наличии заболевания.

При изучении гинекологической заболеваемости было установлено, что 20,8% женщин имеют гинекологические заболевания, среди которых встречаются приблизительно с одинаковой частотой пато-



Программа комплексного медико-социального исследования женщин фертильного возраста.

логия эндометрия матки и яичников (44% и 27% соответственно), 12% – имели осложнения течения беременности и родов, нерегулярный менструальный цикл имеют 55,3% женщин, у 10% было зарегистрировано первичное или вторичное бесплодие. Наиболее распространенными заболеваниями по данным анкетирования являются эндометриоз и хронический двусторонний сальпингофорит.

Уровень сопутствующей соматической заболеваемости составил 580%, у 15% женщин были хронические заболевания, на каждую женщину в среднем приходится 1,3 заболевания, наиболее частым заболеванием являются болезни органов дыхания. По уровню здоровья наблюдаемые женщины были сгруппированы в три оценочные группы: женщин с хорошим здоровьем 35% (первая группа), женщины с удовлетворительным здоровьем – 37% (вторая группа) и женщины с плохим здоровьем – 28% (третья группа), у женщин третьей группы была отмечена минимальная медицинская активность.

Изучение полового поведения показало, что 70,5% женщин считают контрацепцию обязательной, 11,3% – не считают ее необходимой, в основном женщины в качестве контрацепции используют механический метод и прерванный половой акт (83,7%), чаще наблюдаемые женщины принимают решение о контрацепции самостоятельно. В процессе жизнедеятельности наблюдаемые женщины в среднем только в 50% привержены к соблюдению принципов здорового образа жизни.

В целях улучшения состояния здоровья наблюдаемых женщин и повышения их медицинской активности, учитывая, что важнейшим фактором влияющим на здоровье человека является здоровый образ жизни (более 50%), среди них были проведены профилактические беседы по формированию у них здорового образа жизни, правильной организации предупреждения нежелательной беременности и реализации детородной функции в оптимальном возрасте, о целесообразности регулярного наблюдения в женской консультации.

Заключение

По результатам исследования установлено, женщины при рождении ребенка имеют возраст старше 25 лет, что создает условия для формирования нарушений здоровья женщины, каждая третья женщина имела в анамнезе аборт и не использует современные методы контрацепции, значительная часть женщин имеют низкий уровень

медицинской активности, и лишь около половины женщин привержены к соблюдению принципов здорового образа жизни. Для повышения уровня здоровья женщин фертильного возраста необходимо осуществлять активную санитарно-просветительную работу по пропаганде здорового образа жизни с учетом особенностей женского организма.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Российский статистический ежегодник. 2018. *Статистический сборник*. М.: Росстат, 2018.
2. Гараева А.С. Научное обоснование мероприятий по совершенствованию охраны репродуктивного здоровья женщины-матери в условиях высокой рождаемости. Автореф. дисс. ... докт. мед. наук. М.: 2018.
3. Калининская А.А., Абдурашидова П.Б., Малинина О.Ю., Чижикова Т.В., Гайдарова А.Э. Анализ полиморбидности патологии у женщин фертильного возраста. *Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики*. 2017; 2: 13-7.
4. Будревич Г.С., Тищенко Е.М. Медико-социальная проблема репродуктивного здоровья сельских жительниц фертильного возраста. *Журнал Гродненского государственного медицинского университета*. 2013; 23: 94-8.
5. Лебедева-Несевря Н.А., Цинкера М.Ю. Различия в показателях здоровья работающих женщин и мужчин в России. *Журнал социологии и социальной антропологии*. 2018; 21(3): 7-25.

REFERENCES

1. Russian statistical yearbook. 2018. *Statistical collection*. Moscow: Rosstat, 2018. (in Russian)
2. Garayeva A.S. Scientific justification for improving the reproductive health of a mother in the high birth rate of Autoref. Dis. ... Doct. Med. Sciences. Moscow, 2018. (in Russian)
3. Kalininskaya A.A., Abdurashidova P.B., Malinina O.Y., Chizhikova T.V., Gaydarova A.E. Analysis of polymorbidity of pathology in women of childbearing age. *Sovremennye problemy zdoravookhraneniya i meditsinskoy statistiki*. 2017; 2: 13-7. (in Russian)
4. Budrevic G.S., Tishchenko E.M. Medico-social problem of reproductive health of rural women of fertile age. *Zhurnal Grozdnenskogo Gosudarstvennogo Meditsinskogo Universiteta*. 2013; 23: 94-8. (in Russian)
5. Lebedeva-Nesevria N.A., Cinker M.Y. Differences in health indicators of working women and men in Russia. *Zgurnal Sotsiologii i Sotsial'noy Antropologii*. 2018. 21 (3). 7-25. (in Russian)

Поступила 12.09.19
Принята к печати 26.09.19